BẢNG KIỂM
THỰC HIỆN QUY CHẾ HỒ SƠ BỆNH ÁN

Khoa: **Khoa Phòng Khám** Mã HSBA: **25.058691**

Họ tên bệnh nhân: **EMR 03** Năm sinh: 1990

Ngày vào viện: 12 / 08 /2025 Ngày ra viện: / /20

Hướng dẫn đánh giá: (1) Điểm 1: khoa tự đánh giá, Điểm 2: P.KHTH đánh giá.
(2) Tiêu chí đánh giá: Hoàn thành đầy đủ (2 điểm); Hoàn thành một phần (1 điểm); Không thực hiện (0 điểm).

TT	NỘI DUNG	TIÊU CHÍ CẦN ĐẠT	Điểm 1	Điểm 2	Ghi chú
1	**Hành chính**	Bao gồm trang 1 phần bệnh án và phần đầu các biểu mẫu. Ghi chính xác, đầy đủ các cột mục thông tin người bệnh, bao gồm các mã địa chỉ, BHYT...	2		
2		Đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của người hành nghề khám, chữa bệnh	2		
3		Nội dung và chữ viết trong HSBA: phải rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, không viết tắt những từ ngoài quy định, diễn đạt đầy đủ các thông tin thu thập được.	2		
4		Các loại biểu mẫu, kết quả cận lâm sàng được sắp xếp theo đúng nhóm, đúng trình tự.	2		
5	**Chất lượng chẩn đoán**	Hoàn chỉnh HSBA trước 24h (cấp cứu), 36h (không cấp cứu)	2		
6		(*) Chẩn đoán mã ICD 10, cần đủ 02 phần: mã và chữ đúng theo quy định hiện hành.	2		
7		Bệnh sử mô tả được quá trình bệnh lý (khởi phát, diễn tiến, hiện tại, chẩn đoán và điều trị của tuyến trước ...).	2		
8		Khai thác đủ tiền sử bản thân và tiền sử gia đình về các bệnh; tiền sử dị ứng, thói quen làm việc và sinh hoạt... có liên quan đến bệnh hiện tại.	2		
9		Khám: mô tả được các triệu chứng toàn thân, các cơ quan, mô tả rõ cơ quan bị bệnh (triệu chứng dương tính và âm tính có giá trị chẩn đoán).	2		
10		Tờ điều trị số 1: ghi rõ diễn biến bệnh các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng giúp hướng tới chẩn đoán; chẩn đoán ban đầu; các chỉ định cận lâm sàng cần làm thêm; điều trị và chăm sóc.	2		
11		Giờ, ngày, tháng, năm trong toàn bộ bệnh án: ghi rõ và đồng bộ giữa điều trị và chăm sóc.	2		
12		Có đầy đủ chẩn đoán sơ bộ và chẩn đoán xác định	2		
13		Thay đổi chẩn đoán có lập luận, cập nhật vào tờ điều trị	1	2	
14	**Chất lượng điều trị**	Phần diễn tiến bệnh: ghi hàng ngày theo trình tự thời gian (giờ, phút, ngày/tháng/năm); phù hợp với y lệnh thuốc, điều trị, chăm sóc và các chỉ định cận lâm sàng (nếu có).		2	
15		Phần Y lệnh: ghi hàng ngày các chỉ định thuốc, dịch truyền, phẫu thuật/thủ thuật, chăm sóc, dinh dưỡng... ghi đủ và đúng theo quy định; phù hợp với chẩn đoán và diễn tiến bệnh.		1	
16		(*) Chỉ định thuốc, dịch truyền phù hợp với chẩn đoán và diễn tiến bệnh; tuân thủ hướng dẫn và phác đồ điều trị;		1	
17		(*) Chỉ định CLS phù hợp với chẩn đoán và diễn tiến bệnh; tuân thủ hướng dẫn và phác đồ điều trị		1	

TT	NỘI DUNG	TIÊU CHÍ CẦN ĐẠT	Điểm 1	Điểm 2	Ghi chú
18		(*) Có hội chẩn theo quy chế: hội chẩn khi chỉ định kỹ thuật cao (CT, MRI…), hội chẩn chỉ định sử dụng thuốc, hội chẩn chuyển viện…		1	
19		Hoàn thành các biểu mẫu: ***HSBA nội khoa***: biên bản hội chẩn, phiếu sơ kết điều trị, phiếu cam kết, phiếu đánh giá dinh dưỡng... đúng quy định và đầy đủ chữ ký (nếu có). ***HSBA có thực hiện phẫu thuật/thủ thuật***: có thêm phiếu khám tiền mê, phiếu gây mê, bảng kiểm an toàn phẫu thuật, phiếu đếm gạc... phải được ghi và có chữ ký đầy đủ. Sử dụng phiếu phẫu thuật/thủ thuật: áp dụng đối với phẫu thuật (**phải vẽ lược đồ**); thủ thuật có sử dụng phương pháp vô cảm toàn thân hoặc phải thực hiện trong phòng mổ hoặc thủ thuật can thiệp đường mạch máu (không bao gồm tiêm, truyền), đường thở (vẽ lược đồ nếu cần).		1	
20	**Chất lượng chăm sóc**	Ghi chép phiếu theo dõi dấu hiệu sinh tồn, phiếu truyền dịch, phiếu thử phản ứng thuốc, phiếu công khai thuốc, vật tư tiêu hao… đầy đủ rõ ràng, theo thứ tự thời gian, có đủ chữ ký.		1	
21		Phiếu chăm sóc: nhận định diễn tiến và chăm sóc hàng ngày, GDSK, ghi chép can thiệp hàng ngày đầy đủ; ký, ghi rõ họ tên.		1	
22		Người bệnh ra viện: ghi nhận nội dung hoàn thành các thủ tục, GDSK.		1	
23		Lập kế hoạch chăm sóc: đảm bảo đúng thời điểm, chẩn đoán điều dưỡng/vấn đề cần chăm sóc phù hợp, có kế hoạch chăm sóc phù hợp, thực hiện chăm sóc và đánh giá đầy đủ.		1	
24	**An toàn sử dụng thuốc**	Y lệnh thuốc và dịch truyền: đầy đủ rõ ràng theo thứ tự, tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, đường dùng một lần và số lần dùng trong 24 giờ; tên thuốc không được viết tắt, nếu sửa thì phải ký tên bên cạnh.		1	
25		(*) Có đánh số theo dõi ngày dùng những thuốc quản lý đặc biệt: gây nghiện, hướng tâm thần, kháng sinh, corticoid, phóng xạ, điều trị lao.		1	
26		Tuân thủ quy chế kê đơn thuốc gây nghiện, hướng tâm thần.			
27		(*) Có đầy đủ biên bản hội chẩn khi sử dụng các thuốc trong quy định.			
28		Phù hợp với kết quả chẩn đoán, cận lâm sàng, lứa tuổi, cân nặng, tình trạng và cơ địa của người bệnh.			
29		Phù hợp với hướng dẫn điều trị (phác đồ, kết quả kháng sinh đồ ...), đúng liều dùng, đường dùng và không có tương tác bất lợi.			
30		Khi thay đổi thuốc phải phù hợp với diễn tiến và chẩn đoán bệnh, có giải thích cụ thể.			
Tổng cộng			25	15	

Chú ý: (*) Là những tiêu chí bắt buộc phải hoàn thiện nên chỉ có 02 mức đánh giá "Hoàn thành đầy đủ" hoặc "Không thực hiện".

Đánh giá của P.KHTH: ☐ Đạt 50-60 điểm ☒ Không đạt < 50 điểm.

Người giao hồ sơ **Người nhận hồ sơ**

Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Văn Kỹ